

长期护理对中度和重度阿尔茨海默病患者行为和心理症状及认知功能障碍的影响

陈美华，白宇，周贤举，陈伟，何丹，李燕*。

江苏省常州市兴隆巷29号，南京医科大学附属常州第二人民医院神经内科 · 213000

Chen 等人：延长护理对中度和重度阿尔茨海默病患者的影响

本调查的目的是研究延续护理对中度和重度阿尔茨海默病患者的行为和心理症状以及认知功能障碍的影响。将2016年2月至2018年3月南京医科大学附属人民医院收治的中、重度阿尔茨海默病患者共102例

，随机分为观察组和对照组。对照组接受常规健康教育和护理

观察组在出院后接受额外的扩展护理计划1年，包括日常生活能力训练、身体功能训练、语言训练、记忆训练、音乐治疗、心理护理支持和患者的线下集体活动。两组患者的阿尔茨海默病的行为病理评估量表、蒙特利尔认知评估和Barthel日常生活活动的得分进行了比较。两组入院时阿尔茨海默病的行为病理评估量表、蒙特利尔认知评估和Barthel日常生活活动的得分没有显著差异。一年后，观察组的阿尔茨海默病的行为病理评估量表得分明显低于对照组 ($P<0.05$)，观察组的蒙特利尔认知评估得分和Barthel日常生活活动得分明显高于对照组 ($P<0.05$)。本研究的扩展护理方案明显改善了阿尔茨海默病患者的行为和心理症状，包括焦虑、恐惧、幻觉、妄想、情绪障碍、攻击性行为、行为障碍和昼夜节律紊乱。同时，还可以明显改善阿尔茨海默病患者的认知能力，提高他们处理日常生活活动的的能力。

关键字。阿尔茨海默病，扩展护理，行为和心理症状，认知功能，日常生活活动能力

阿尔茨海默病 (AD) 是一种易发于老年人的神经退行性疾病，神经系统有病理变化，如脑回沟增宽、大脑皮层弥漫性萎缩和神经纤维缠结^[1]。它可以严重影响患者的健康和社会稳定。在AD患者中发现一些神经功能障碍，如不可逆的、进行性的记忆障碍、残疾、痴呆、失语和失明^[2]。与血管性痴呆和创伤性痴呆不同，AD的病因不明，导致临床治疗措施有限。AD护理工作难度大，国内护理经验和理念相对落后，对护理医生、护理工作者和家属来说，AD护理工作仍然具有挑战性。积极而有策略的AD护理可以最大限度地提高患者的功能和独立性。然而，由于AD患者通常在家中或养老院接受护理，医生和护士很难向AD患者及其护理人员普及先进的护理理念。延伸护理是指从医院到家庭或社区的持续跟踪和指导^[3]。在本研究中，我们为中度和重度AD患者及其护理人员设计并实施了延伸护理方案。通过比较接受扩展护理的患者和接受常规护理的患者的行为和心理症状以及认知功能障碍程度，探讨了扩展护理对AD患者的积极作用和预后价值。

这可以为AD的延伸护理提供临床依据和参考，同时也为其他神经科疾病的护理方案开辟思路。本研究共纳入2016年2月至2018年3月南京医科大学附属人民医院收治的102例中、重度AD患者。纳入标准为，符合所有中度和重度AD相关诊断标准的患者^[4]。

；有不同程度行为和心理症状的患者；家属自愿参与研究并签署知情同意书的患者。排除标准为，治疗前2个月使用过或停用过抗精神病药物的患者；有严重的心、肝、肺、肾等重要器官疾病的患者，AD患者合并其他精神疾病。按照随机数字法，将患者分为对照组和观察组，各51例。对照组男23例，女28例（年龄63-82岁，平均年龄 (71.43 ± 5.14) 岁），病程4-12年（平均 7.44 ± 2.15 年）。观察组中，男性24人，女性27人（年龄62-84岁，平均年龄 72.38 ± 4.27 岁）；病程5-10年（平均病程 7.13 ± 1.64 年）。这两组之间的基线数据没有统计学差异。这项研究得到了医院伦理委员会的批准。

出院时，患者及其家属得到了常规的健康教育和护理指导。

***通信地址**

电子邮件：wenlin264161@163.com

护士们根据病人的情况对他们进行随访。出院后，每3个月对他们进行一次电话随访。随访内容主要包括自理能力、心理健康、日常睡眠和饮食质量。我们成立了一个扩展护理团队，包括1名神经内科医生和5名具有丰富AD护理经验的护士。团队成员积极参加研究，并接受了扩展护理计划的培训。除对照组的常规护理措施外，还采取了以下延伸护理措施。实施出院指导计划，为出院患者建立微信群，开通热线电话，在线提供AD康复、护理和用药指导。微信群和热线主要有以下功能，查询功能。患者在群内发布或打电话提出护理和用药问题后，指定的护理小组成员应在1天内回复，并在微信群内组织相应的病例延伸分析和讨论。对于个别患者和护理人员的隐私问题，采用微信私聊或电话联系。当问题无法远程解决时，要求患者回院进一步咨询。发布有关AD护理知识的教育计划和可以帮助患者治疗的音乐和视频。知识教育计划的设计从日常生活能力训练、身体机能训练、语言训练、记忆力训练等方面综合考虑。每天上午和下午各发布一次培训教学视频，内容简单易懂，操作性强。此外，为了提高培训效果，这些视频是循环发布的。鼓励护理人员将患者的训练成果发布到微信群中进行展示，护理团队采用语音或视频的方式给予积极鼓励和指导。加强医生、护士和患者之间的沟通，如果患者或护理人员一个月没有出现在群聊中，护理小组成员询问原因，告知积极参与群聊的意义，并建议参与。心理护理工作包括在随访过程中，护理组成员与患者讨论其病史和期望，听取患者及其家属的回忆、成就、生活期望和生活经历^[5]，以帮助患者找回记忆，恢复希望

为未来。此外，他们还安慰和疏导其家属和护理人员的烦恼和痛苦，并指导护理人员采取对策，协助患者或护理人员，在随访中出现严重的心理症状时，及时就医进行专业的心理治疗。随访人员通过介绍以往的案例和心理咨询，提高了家庭决策人对AD患者的支持和鼓励^[6]

。每2个月组织一次线下活动，包括沙盘游戏、简易智能玩具等集体活动^[7]

，提高患者对美好生活的向往和身体功能锻炼。本研究采用阿尔茨海默病的行为病理评估量表（BEHAVE-AD）^[8]

。医生对患者的行为和心理症状进行了评分。BEHAVE-

AD有7个维度，焦虑、恐惧、幻觉、妄想、情绪障碍、攻击性行为、行为障碍、昼夜节律紊乱，共25个项目。每个项目的得分从0到3分。分数越高，患者的精神行为症状越严重。蒙特利尔认知评估量表（MoCA）^[9]

和小型精神状态检查量表（MMSE）被用来评估两组的认知功能。MoCA量表有8个维度（30分），包括命名、语言、记忆、定向、注意、执行能力、抽象思维和延迟记忆。分数越高，患者的认知能力越强。巴特尔日常生活活动量表（BADL）被用来评估日常生活能力。BADL量表有四个维度，包括吃饭、洗澡、穿衣和上厕所。每个维度的得分是1-4分，总分是16分，得分越高，患者的基本生活活动能力越好。采用SPSS

22.0软件进行数据分析，计量数据以均数±标准差表示，采用T检验进行比较， $P<0.05$ 表示差异有统计学意义。两组入院时的BEHAVE-

AD评分无明显差异。随访1年后，观察组的BEHAVE-

AD评分明显低于对照组（ $P<0.05$ ），如表1所示。

两组入院时的MoCA评分没有明显差异。随访1年后，观察组的MoCA评分明显低于对照组。

表2），而对照组则没有（ $P<0.05$ ）。没有出现

表1:观察组和对照组的行为学得分

集团	N	录取得分	1年后后续
观察组	51	19.32±3.53	7.21±2.88
控制组	51	19.47±3.37	10.37±2.17
t		0.219	6.258
p		0.827	0.000

表2：观察组和对照组的MoCA得分情况

集团	N	录取分数	1年后的随访
观察组	51	17.76±3.68	14.64±2.38
控制组	51	17.04±3.52	12.59±2.70
t		1.010	4.068
p		0.315	0.000

两组入院时的BADL评分有明显差异。随访1年后，观察组的BADL评分明显高于对照组（ $P<0.05$ ），如表3所示。AD是一种进行性的神经退行性疾病。由于定向力、认知功能、记忆能力和自理能力的逐渐丧失，AD患者会出现记忆衰退、迷宫和痴呆。有些AD患者甚至会出现被杀的错觉、暴力等特殊情况，出院后需要特殊照顾。此外，目前还没有能够完全治愈AD或有效改善AD症状的治疗方法。奥氮平等药物可以改善记忆和控制精神症状，但只能延缓疾病^[10]

。美满霉素和多奈哌齐等药物也可以通过提高神经递质乙酰胆碱的水平来增强记忆和认知功能。AD患者的病程很长，可长达15至20年。患者需要长期护理，因为病程的个体差异很大^[11]

。护理AD患者给社会和家庭带来了沉重的负担。《健康中国2030规划纲要》重点关注老年痴呆患者在生命末期的长期护理，提高老年痴呆患者的生活质量，维护老年痴呆患者的尊严。然而，由于AD患者一般由家庭或社区照顾，缺乏相应的护理手段和经验，会加重AD患者的病情恶化。如何将医院的护理经验延伸到家庭和社区，是一个值得临床思考的课题。延伸护理，这一概念诞生于1947年^[12]，是指

从医院到家庭或社区的持续跟踪和指导，保证了护理工作的连续性。延伸护理在中国的发展相对缓慢，还处于小范围的探索阶段。2016年发布的《中国护理事业发展规划纲要（2016-2020年）》明确提出，要把延伸护理作为“十三五”期间的重点发展任务。鼓励医疗机构逐步完善护理服务的内容和模式，为出院患者提供多种延伸护理服务。本研究设计了一套系统的、可操作的延伸护理方案，其目的是实时、渗透性地延伸护理干预模式。主要依托微信、家访、电话等方式，建立医患家属沟通渠道、护患家属互动模式、医患互助模式，促进AD预后，使AD临床护理从医院向社会扩散，合理配置临床资源和社会资源。结果显示，接受延伸护理的患者的行为和心理症状较对照组明显减少，焦虑、恐惧、幻觉、情绪障碍、妄想、攻击性行为、行为障碍、昼夜节律紊乱的发生率均有所降低和减缓。这可能与组织患者玩沙盘游戏和简单的智力玩具，与患者讨论随访期间的病史和期望，倾听患者及其家属的回忆、成就、生活期望和生活经历等活动有关。此外，MoCA评分结果显示，接受延续护理的患者在延续护理1年后，其认知功能明显优于对照组。这可能与微信日常推送中的音乐和视频可以辅助患者治疗的做法有关。据报道，音乐治疗可以影响海马体、胼胝体、伏隔核、听觉皮层

表3：观察组和对照组的Badl评分

Group	N	录取分数	1年后后续
观察组	51	14.53±1.77	11.41±1.08
控制组	51	15.02±1.82	9.31±1.52
t		1.378	8.043
p		0.171	0.000

和许多其他脑区，而AD与这些脑区的失效和退化有关。因此，各种形式的音乐疗法可以有效地刺激这些脑区，延缓其退化速度，从而延缓疾病的发生[13]

。最后，本研究还采用了BADL量表来比较患者的日常生活能力，发现接受扩展护理的患者在穿衣、吃饭、上厕所和洗澡方面的日常生活能力明显优于对照组。延伸护理方案开展了日常生活能力训练，对AD患者进行了鼓励和指导，对患者及家属提出的问题进行了积极的回应，这些都作为案例进行了分析和推广。得到了广大患者和家属的高度赞扬。延伸护理在AD中的应用还存在一些问题需要解决，如配套制度的完善和评价体系的建立。本研究中的延伸护理是免费提供给患者的。在本研究过程中，可能会出现一些问题，如护理人员的疲劳和安全问题、护理人员的积极性和满意度问题，这些问题可能会干扰本研究的结果。因此，护理人员的收费和分配需要改进，以便在AD中推广扩展护理。

鸣谢。

这项工作得到了国家自然科学基金的支持（81471338）。

利益冲突。

作者宣布没有利益冲突。

参考文献

1. Nowrangi MA.阿尔茨海默氏症的神经精神方面。从机制到治疗。Psychiatr Clin N Am 2020; 43:383-97.
2. Lancot KL, Amantiek J, Ancoli-Israel S, Arnold SE, Ballard C, Cohen-Mansfield J, et al. Alzheimer's disease的神经精神迹象和症状。新的治疗范式。阿尔茨海默氏症与痴呆症。Translational Research & Clinical Interventions 2017;3:440-9.

3. Xue Y, Jian S, Tong L, Weixin H. GW25-e4570持续护理干预对老年慢性病患者生活质量的影响。J Am Coll Cardiol 2014; 64:C222.
4. Jack Jr CR, Bennett DA, Blennow K, Carrillo MC, Dunn B, Haeblerlein SB, et al. NIA-AA研究框架：走向阿尔茨海默病的生物学定义。Alzheimers Dement 2018; 14:535-62.
5. NIA-AA研究框架。迈向生物学定义的阿尔茨海默病。Alzheimers Dement 2018; 14:535-62.
6. Zou G, Li Y, Xu R, Li P. 复原力和积极情绪有助于降低中国胃癌患者的癌症相关疲劳。J Clin Nurs 2017; 27:e1412-8.
7. Toles M, Song MK, Lin FC, Hanson LC.患有晚期痴呆症的养老院居民的家庭决策人对围绕生命末期护理的沟通质量的看法。J Am Med Dir Assoc 2018; 19:879-83.
8. Di Giulio P, Finetti S, Giunco F, Basso I, Rosa D, Pettenati F et al. The Impact of Nursing Homes Staff Education on End of Life Care in Residents with Advanced Dementia:A Quality Improvement Study.J Pain Symptom Manage 2019; 57:93-9.
9. Gamba P, Testa G, Staurengi E, Gargiulo S, Poli G, Leonarduzzi G. 脑啡肽在阿尔茨海默病中的银边：sirtuin 1参与神经保护 Free Radic Biol Med 2017; 108:S2.
10. Weinstein A, Gujral S, Butters M, Bowie C, Fischer C, Flint A et al. 诊断认知衰退。比较NIA-AA和DSM-5的方法。Am J Geriatr Psychiatry 2020; 28:S79-80.
11. Benek O, Korabecny J, Soukup O. A Perspective on Multi-target Drugs for Alzheimer's disease.Trends Pharmacol Sci 2020; 41:434-45.
12. Lopez OL, Kuller LH.衰老和相关认知障碍的流行病学。阿尔茨海默病和其他痴呆症的患病率和发病率。Handb Clin Neurol 2019; 167:139- 48.
13. Dualan JJ.以护理人员为导向的过渡性护理计划在促进护理人员为烧伤病人的家庭护理做好准备方面的效果。J Burn Care Res 2020; 47: S2-3.
14. Gulliver A, Pike G, Banfield M, Morse AR, Katruss N, Pescud M等人，对阿尔茨海默病和痴呆症患者的音乐参与计划的评估。试点试验的研究方案。Contemp Clin Trials Commun 2019; 15:100 419.

这是一篇根据知识共享署名-非商业性-相同方式共享3.0许可条款发布的开放存取文章，该条款允许其他人在非商业性的基础上重新混合、调整和构建该作品，只要注明作者和新的创作在相同的条款下许可。

这篇文章最初发表在

"临床和临床前制药学的生物医学研究

"专刊上·印度J Pharm Sci 2020;82 (3) Spl issue7;5-9